

ติดต่อ

091-031-9522

Bowornthat.ker@student.mahidol.edu

ห้อง 607 หอพักมหิตลาคาร เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น: ก้าว

วันเกิด: 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2545

ภูมิลำเนา: 322/4 หมู่ 1 ต.ไผ่ล้อม อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์

สัญชาติ: ไทย

ศาสนา: พุทธ

หมู่โลหิต: O

ส่วนสูง / น้ำหนัก: 190 ซม. / 104 กก.

ครอบครัว

อาศัยอยู่กับบิดาและพี่ชาย 2 คน

บวรทัต เกิดส่ง (ก้าว) / Bowornthat Kerdsong (Kao)

ประวัติส่วนตัวโดยสังเขป

นักศึกษาแพทย์ชั้นปีสุดท้าย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ผู้มุ่งสู่เส้นทางอาจารย์แพทย์ทางศัลยศาสตร์ ข้าพเจ้าเป็น**ผู้เรียนรู้ด้วยตนเองที่พัฒนาได้เร็วที่สุดภายใต้การชี้แนะของอาจารย์ที่ดี** แสวงหาความรับผิดชอบที่เกินกว่าระดับชั้นของตน และมองความผิดพลาดเป็นโอกาสในการปรับตัว มิใช่การถอยหลัง ปัจจุบันข้าพเจ้า**ยังพิจารณาระหว่างสาขาศัลยศาสตร์หัวใจ หลอดเลือด และทรวงอก กับสาขาศัลยศาสตร์ตับ ตับอ่อน และทางเดินน้ำดี** ซึ่งเป็นสาขาของคำถามวิจัยที่ข้าพเจ้าริเริ่มเองและตั้งใจตัดสินใจจากการปฏิบัติงานทางคลินิกอย่างต่อเนื่องในช่วงชดใช้ทุน

สาขาที่สนใจ

อยู่ระหว่างพิจารณา

1 · ศัลยศาสตร์หัวใจ หลอดเลือด และทรวงอก (CVT) — เวชปฏิบัติที่ขับเคลื่อนด้วยหลักฟิสิกส์และตรรกะ การผ่าตัดหลอดเลือดแดงใหญ่ทั้งแบบเปิดและผ่านสายสวน (Aortic and endovascular surgery) และผลลัพธ์ที่ชัดเจนรวดเร็ว

2 · ศัลยศาสตร์ตับ ตับอ่อน และทางเดินน้ำดี (HPB) — กายวิภาคศาสตร์ที่ข้าพเจ้าสนใจมาตั้งแต่ชั้นพรีคลินิก คำถามวิจัยเรื่องแรกที่ข้าพเจ้าริเริ่มเอง และคณาจารย์ HPB ทั้งศิริราชและธรรมศาสตร์ซึ่งเป็นแบบอย่าง (role model) ของข้าพเจ้า

เปิดรับสาขาอื่น

ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ และสาขาย่อยอื่นของศัลยศาสตร์ทั่วไป

คุณลักษณะเด่น

ใฝ่พัฒนาและเรียนรู้ด้วยตนเอง ขอโอกาสนำเสนอด้วยตนเองที่หน่วย HPB ธรรมศาสตร์ จาก Journal club ในชั้นปีที่ 5 สู่ Topic presentation เรื่อง Bile duct injury ในชั้นปีที่ 6 นำเสนอในที่ประชุม Grand round ศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก ศิริราช (Blunt thoracic aortic injury) และขออยู่เวรเพิ่ม รวมถึงเวรเฝ้า ICU ตลอดคืน

คิดริเริ่มโจทย์ใหม่ ริเริ่มคำถามวิจัยเรื่องถุงน้ำดีอักเสบเฉียบพลันระดับที่ 2 และนำเสนอต่อคณาจารย์ HPB ศิริราช ซึ่งช่วยปรับขอบเขตการศึกษาให้เหมาะสม และออกแบบระบบสติกเกอร์สัญลักษณ์เพื่อลดอัตราการขาดนัดในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง

E-PORTFOLIO
bowornthat9522.github.io

รับฟังก่อนลงมือ เรียนรู้จากผู้ร่วมงานทุกระดับ รวมถึงรุ่นน้อง คลี่คลายข้อพิพาทเรื่องการจัดสรรสนามบาสเกตบอลที่ยืดเยื้อมานาน ด้วยการทำความเข้าใจความต้องการที่แท้จริงของแต่ละฝ่าย

มั่นคงเมื่อเผชิญความผิดพลาด ยอมรับความผิดพลาดได้เร็วและเดินหน้าต่อ มีเวทเทรนนิ่งต่อเนื่อง 6 ปี และกำลังฝึก MMA มวยไทย และ Brazilian jiu-jitsu เป็นรากฐานความแข็งแกร่งทั้งกายและใจ

ใจรักการสอน ชอบสอนข้างเตียงในหอผู้ป่วย เป็นประธานโครงการเวิร์กช็อปอัลตราซาวด์สำหรับนักศึกษาแพทย์ และเป็นพี่เลี้ยงนักเรียนมัธยมในชนบท

ประวัติการศึกษา

2564–ปัจจุบัน **แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.)** คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 · เกรดเฉลี่ยสะสม 3.66 · คาดสำเร็จการศึกษา พ.ศ. 2570

2558–2563 โรงเรียนอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

ความสามารถทางภาษา

2569 CU-TEP (Chulalongkorn University Test of English Proficiency) 17 ตุลาคม 2569 — 99/120 ระดับ Proficient User (Advanced)

ความสามารถด้านหัตถการ

- หัตถการพื้นฐานตามมาตรฐานแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป — Thoracentesis, Paracentesis, Lumbar puncture, Intercostal drainage, Excision, Debridement, Incision and drainage
- การใส่สายสวนหลอดเลือดดำส่วนกลางภายใต้การกำกับดูแล (Ultrasound guide, Seldinger technique)
- การผ่าตัดไส้ติ่งแบบเปิดในฐานะผู้ผ่าตัดหลักภายใต้การกำกับดูแล ปฏิบัติครั้งแรกในช่วงท้ายของชั้นปีที่ 5 ก่อนขึ้นชั้นปีที่ 6
- การเย็บแผลและผูกปมได้ทั้งสองมือ — One-hand และ Two-hand square knot, Sliding knot และ Surgical knot โดยให้ความสำคัญกับ knot security

เหตุผลในการเลือกสาขาศัลยศาสตร์

ศัลยศาสตร์ให้**ความเชื่อมโยงโดยตรงระหว่างการรักษากับผลลัพธ์** ในระดับที่ข้าพเจ้าไม่พบในสาขาอื่น ระหว่างรายวิชาเลือกศัลยศาสตร์ทั่วไป ณ โรงพยาบาลพุทธชินราช ในชั้นปีที่ 5 ข้าพเจ้าขอขึ้นเวรเพิ่มเติม และได้ดูแลผู้ป่วยชายอายุ 19 ปี ที่มาด้วยไส้ติ่งอักเสบเฉียบพลัน ตั้งแต่การประเมินแรกรับที่ห้องฉุกเฉิน ผ่านการผ่าตัดในฐานะผู้ผ่าตัดหลักภายใต้การกำกับดูแลของแพทย์ประจำบ้านศัลยศาสตร์ทั่วไป จนจำหน่ายกลับบ้าน การรับผิดชอบผู้ป่วยหนึ่งรายตลอดเส้นทางนี้ยืนยันการเลือกสาขาของข้าพเจ้า

เหตุผลในการสมัครใช้ทุน ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตัวเลือกแรกและตัวเลือกเดียว ธรรมศาสตร์คือสถาบันแรกและสถาบันเดียวที่ข้าพเจ้าเลือกตลอดการปฏิบัติงานชั้นปีที่ 6 ข้าพเจ้ามิได้สมัครหรือเข้ารับการสัมภาษณ์แพทย์ใช้ทุนที่สถาบันอื่น

ความคุ้นเคยกับสถาบัน จากรายวิชาเลือกที่ธรรมศาสตร์ 4 รายวิชา รวม 8 สัปดาห์ ได้แก่ ศัลยศาสตร์หัวใจหลอดเลือด และทรวงอก และศัลยศาสตร์ตับ ตับอ่อน และทางเดินน้ำดี ในชั้นปีที่ 5 ตามด้วยศัลยศาสตร์ตับ ตับอ่อน และทางเดินน้ำดีอีกครั้ง และศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ (อยู่ระหว่างปฏิบัติงาน) ในชั้นปีที่ 6 รวมถึงกิจกรรม One-Day Journey in Cardiothoracic Surgery 2026 ความเข้าใจต่อลักษณะผู้ป่วย ระบบงาน และวัฒนธรรมการเรียนการสอน**จึงมาจากประสบการณ์ตรง มิใช่ชื่อเสียงของสถาบัน**

ความครอบคลุม ณ จุดตัดสินใจ เส้นทางอาจารย์ศัลยแพทย์ผูกพันกับสาขาย่อยหนึ่งไปอีกยี่สิบถึงสามสิบปี **ทั้งสองหน่วยที่ข้าพเจ้าพิจารณาอยู่ ณ สถาบันแห่งนี้** ควบคู่กับหน่วยอื่นในภาควิชา การตัดสินใจจึงตั้งอยู่บนการปฏิบัติงานจริงอย่างต่อเนื่อง มิใช่การสัมผัสงานเพียงระยะสั้น

การสอนตั้งแต่ต้น ด้วยสถานะโรงเรียนแพทย์ ธรรมศาสตร์เปิดโอกาสให้ข้าพเจ้า**เริ่มสอนนักศึกษาแพทย์ตั้งแต่ช่วงชดใช้ทุน** ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่สถาบันที่ไม่มีการเรียนการสอนให้ไม่ได้

การเลือกหลักสูตร ข้าพเจ้าเลือกหลักสูตรแพทย์ใช้ทุนสาขาศัลยศาสตร์ตามระบบปกติ แทนเส้นทางที่เข้าสอบวุฒิบัตรได้เร็วกว่าโดยเจตนา เป้าหมายคือ**การฝึกอบรมเฉพาะทางต่อยอด ณ สถาบันชั้นนำในต่างประเทศ แล้วกลับมาปฏิบัติงานในเส้นทางวิชาการในประเทศไทย** ซึ่งต้องอาศัยทั้งความสามารถในการผ่าตัดและผลงานวิจัยที่แข่งขันได้ ระยะเวลาที่เพิ่มขึ้นจึงเป็นการลงทุน มิใช่ความล่าช้า

แผนการศึกษาต่อภายหลังสิ้นสุดการชดใช้ทุน

ระหว่างช่วงชดใช้ทุน สั่งสมประสบการณ์การผ่าตัดและหัตถการทั่วทั้งภาควิชา สอนนักศึกษาแพทย์ และดำเนินงานวิจัยต่อเนื่อง ทั้งงานวิจัยถุงน้ำดีอักเสบเฉียบพลันระดับที่ 2 ซึ่งเก็บข้อมูลต่อผ่านฐานข้อมูลออนไลน์ และงานวิจัยแบบไปข้างหน้าที่ข้าพเจ้าออกแบบเองอีกหนึ่งโครงการ **กำหนดตัดสินใจเลือกสาขาย่อยภายในปีที่ 2 หรือ 3 ของการชดใช้ทุน**

การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน เส้นทางเป็นไปตามการตัดสินใจนั้น คือ**หลักสูตรศัลยศาสตร์ทรวงอกต่อเนื่อง 5 ปีโดยตรง** หรือศัลยศาสตร์ทั่วไป 4 ปี ต่อด้วยการฝึกอบรมต่อยอด HPB อีก 2 ปี การเลือกสถาบันจะพิจารณาจากโอกาสด้านงานวิจัย ปริมาณผู้ป่วย เทคโนโลยีการผ่าตัด และวัฒนธรรมที่มอบความรับผิดชอบในการผ่าตัดตามลำดับขั้น

ภายหลังจากนั้น การฝึกอบรมเฉพาะทางต่อยอด ณ ต่างประเทศ แล้วกลับมาปฏิบัติงานในเส้นทางวิชาการ เพื่อ**แปรองค์ความรู้ให้เป็นขีดความสามารถของสถาบัน มิใช่ความเชี่ยวชาญเฉพาะบุคคล**

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

ผลลัพธ์ของการรักษาด้วยการผ่าตัดในผู้ป่วยถุงน้ำดีอักเสบเฉียบพลันระดับที่ 2 (Grade II) : การวิเคราะห์เปรียบเทียบระยะเวลาที่เหมาะสมในการผ่าตัด การระบายถุงน้ำดีผ่านผิวหนัง และประสบการณ์ของศัลยแพทย์ ณ โรงพยาบาลศิริราช

ผู้วิจัยหลักในส่วนของนักศึกษาแพทย์ ภายใต้หัวหน้าโครงการวิจัย ผศ.นพ.พลสิทธิ์ แสงเสรีสถิตย์ และผู้ร่วมวิจัย ศ.นพ.ยงยุทธ ศิริวัฒนอักษร และ อ.นพ.ชาญวิทย์ อัศวศิริศิลป์ สาขาวิชาศัลยศาสตร์ตับ ตับอ่อน และทางเดินน้ำดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล **ข้าพเจ้าเป็นผู้ริเริ่มคำถามวิจัยและนำเสนอต่อคณาจารย์สาขาวิชาฯ ซึ่งช่วยปรับขอบเขตและรูปแบบการศึกษาให้เหมาะสม**

การศึกษาย้อนหลังจากเวชระเบียน เลขที่โครงการวิจัย 434/2569 (IRB4) โครงร่างการวิจัยออกแบบให้เก็บข้อมูลต่อเนื่องผ่านฐานข้อมูลออนไลน์ และบันทึกชุดตัวแปรที่เพียงพอต่อการต่อยอดเป็นการศึกษาอื่นได้อีกหลายเรื่อง

การนำเสนอผลงานวิชาการ

2569 Bile duct injury after cholecystectomy: from recognition to reconstruction — Topic presentation หน่วยศัลยศาสตร์ตับ ตับอ่อน ทางเดินน้ำดี และการปลูกถ่ายอวัยวะ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 29 ตุลาคม 2569

2569 การพัฒนาคุณภาพ : ระบบสติกเกอร์สัญลักษณ์เพื่อลดอัตราการขาดนัดติดตามการรักษาในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง — การนำเสนอแบบบรรยาย ประชุมวิชาการเวชศาสตร์ชุมชนศิริราช โรงพยาบาลด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

2569 การปกป้องการทำงานของไต : การหลีกเลี่ยงยาชุดที่ไม่ได้สั่งจ่ายโดยแพทย์เพื่อชะลอการดำเนินไปของโรคไตเรื้อรัง — การนำเสนอแบบบรรยาย ประชุมวิชาการเวชศาสตร์ชุมชนศิริราช โรงพยาบาลด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

2567 การรักษาด้วยการผ่าตัดในผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักที่มีกลุ่มอาการลินช์ : การผ่าตัดแบบขยายขอบเขตเทียบกับการผ่าตัดเฉพาะส่วน — การนำเสนอแบบบรรยายและโปสเตอร์ งาน Siriraj Research Day

การประชุมและเวิร์กช็อป

2569 เวิร์กช็อป TEVAR Foundation คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 7–8 กันยายน 2569 — เข้าร่วมตามคำเชิญ

2569 กิจกรรม One-Day Journey in Cardiothoracic Surgery 2026 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 8 สิงหาคม 2569

รายวิชาเลือกทางคลินิก

2569 ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ (Trauma and Critical Care) ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ (1–14 พฤศจิกายน 2569 อยู่ระหว่างปฏิบัติงาน)

2569 ศัลยศาสตร์ตับ ตับอ่อน ทางเดินน้ำดี และการปลูกถ่ายอวัยวะ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ (19–30 ตุลาคม 2569, 2 สัปดาห์)

2569 ศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ (2 สัปดาห์)

2569 ศัลยศาสตร์ตับ ตับอ่อน ทางเดินน้ำดี และการปลูกถ่ายอวัยวะ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ (2 สัปดาห์)

2569 สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก (2 สัปดาห์)

2568 สาขาวิชาศัลยศาสตร์ตับ ตับอ่อน และทางเดินน้ำดี ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (3 สัปดาห์)

2568 สาขาวิชาศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (3 สัปดาห์)

2568 สาขาวิชาโรคหัวใจ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2 สัปดาห์)

2568 ภาควิชาอายุรศาสตร์ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก (2 สัปดาห์)

ภาวะผู้นำและกิจกรรมนอกหลักสูตร

2568–2569 **รองประธาน ชมรมศัลยศาสตร์ศิริราช**
ประธานโครงการ เวิร์กช็อป “Ultrasound in Surgical Emergency” — พัฒนาความสามารถด้านการตรวจอัลตราซาวด์ ณ จุดดูแลผู้ป่วยให้แก่นักศึกษาแพทย์
ผู้ร่วมจัดโครงการ เวิร์กช็อป “Essential of Burn Management & Military Medicine” ภายใต้ความร่วมมือกับวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

2567 **ประธาน ชมรมบาสเกตบอล ศิริราช (ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาชมรม)**
เป็นกัปตันและบริหารจัดการทีมจนคว้าแชมป์ระดับประเทศ 3 สมัยติดต่อกัน
อำนวยการจัดการแข่งขันระหว่างคณะแพทยศาสตร์ และนัดกระชับมิตรระหว่างสถาบันมากกว่า 5 นัด เพื่อสร้างเครือข่ายทางวิชาชีพระหว่างสถาบัน
ยุติข้อพิพาทเรื่องการจัดสรรสนามที่สะสมมาหลายทศวรรษ ระหว่างบุคลากรของโรงพยาบาล ศิษย์เก่า และนักศึกษา ด้วยการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้สนาม แต่งตั้งผู้แทนของแต่ละกลุ่ม และวางระบบตารางจัดสรรที่โปร่งใส ซึ่งยังคงใช้งานอยู่จนถึงปัจจุบัน
ปรับโครงสร้างการระดมทุนของชมรมสู่ช่องทางจำหน่ายสินค้าที่ระลึกออนไลน์ ส่งผลให้กำไรเพิ่มขึ้นร้อยละ 200 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

2566 **กรรมการนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล**
ประธานหอพักนักศึกษาชาย และกรรมการนักศึกษาชั้นปีที่ 3 — ผลักดันสวัสดิการนักศึกษาและบริหารจัดการงานหอพัก
ประธานจัดงาน การแข่งขันกีฬาภายใน SI 132 — วางแผนงานและจัดสรรงบประมาณ

2566 นักแสดงนำ ละครเวทีประจำคณะฯ Siriraj Family Concert 2023

รางวัลและเกียรติประวัติ

2569 อันดับที่ 1 ของนักศึกษาแพทย์ (อันดับที่ 6 จากผู้เข้าร่วมทั้งหมด ซึ่งรวมบุคลากรสหวิชาชีพ) การแข่งขันตอบคำถาม กิจกรรม One-Day Journey in Cardiothoracic Surgery 2026 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2565–2567 แชมป์ 3 สมัยติดต่อกัน การแข่งขันกีฬานักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย (กีฬาเข็มสัมพันธ์)

2566 ชนะเลิศ การแข่งขันโต้วาทีทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

2562 ผ่านการคัดเลือก ค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. สาขาฟิสิกส์ (ค่ายที่ 2) มหาวิทยาลัยนเรศวร

2561 ผ่านการคัดเลือก ค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. สาขาคณิตศาสตร์ (ค่ายที่ 2) มหาวิทยาลัยนเรศวร

งานบริการสังคม

2569 วิทยากรและพี่เลี้ยง โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 อำเภอด่านช้าง — ให้คำแนะนำแก่นักเรียนมัธยมศึกษาในพื้นที่ชนบทเรื่องการสอบเข้าคณะแพทยศาสตร์และแนวทางการศึกษาต่อ

2566 ผู้ดูแลฐานกิจกรรม โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 · หัวหน้ากลุ่มและพี่เลี้ยง ค่ายแนะแนวสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย

2565 หัวหน้าฝ่ายต้อนรับ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล — อำนวยการงานฝ่ายต้อนรับในพิธีพระราชทานเพลิงศพผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาทางการแพทย์ ประสานงานให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมเกียรติแก่ครอบครัวผู้วายชนม์

ความสนใจนอกวิชาชีพ

- บาสเกตบอล เวทเทรนนิ่ง วิ่ง และว่ายน้ำ
- พอดแคสต์ด้านการพัฒนาตนเองเชิงวิชาชีพ
- การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในงานคลินิกและงานวิจัย
- การท่องเที่ยวภายในประเทศ

กีฬา

- บาสเกตบอลตั้งแต่อายุ 12 ปี ตำแหน่ง Center
- กัปตันทีม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล พ.ศ. 2567
- แชมป์ 3 สมัยติดต่อกัน การแข่งขันกีฬานักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2565–2567 โดยรับหน้าที่กัปตันในสมัยที่ 3
- เวทเทรนนิ่งต่อเนื่อง 6 ปี รูปแบบ Full-body Hypertrophy · Deadlift 1RM 200 กก. · Squat 1RM 140 กก.
- รักษาไว้ได้ตลอดช่วงตารางเวรที่หนักที่สุด และเป็นวิธีหลักในการจัดการความเครียดจากการทำงานของข้าพเจ้า